



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Program Kerja Komite Mutu
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Disusun oleh:

Komite Mutu Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ari Putriani, Sp.PK)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CHAE.)

Ditetapkan oleh:

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang,



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit ini dapat tersusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara menyeluruh, dengan berpedoman pada standar mutu, keselamatan pasien, serta ketentuan akreditasi rumah sakit yang berlaku.

Program ini akan senantiasa dilakukan evaluasi secara berkala dan disempurnakan apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan maupun kebutuhan rumah sakit. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, serta kerja sama dalam proses penyusunan program ini.

Malang, 15 Desember 2025

Penyusun

Komite Mutu Rumah sakit

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Dasar Hukum 1

 1.3 Tujuan..... 1

BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 2

 2.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 2

BAB III CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 4

BAB IV SASARAN..... 11

BAB V JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 12

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI 14

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan pasien maka Rumah Sakit Prima Husada Malang perlu mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) yang menjangkau ke seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Rumah sakit telah menetapkan komite PMKP untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan lebih baik.

Program ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua aspek pelayanan .

Pendekatan ini mencakup:

1. Pengukuran mutu indikator termasuk indikator nasional mutu (INM), indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP RS) dan indikator mutu prioritas unit (IMP unit).
2. Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan.
3. Mengurangi variasi dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dalam melakukan pengukuran dengan *clinical pathway*.
4. Mengukur dampak efisiensi dan efektifitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM.
5. Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien .
6. Penerapan sasaran keselamatan pasien.
7. Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen.
8. Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
9. Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf.

Guna mencapai hal itu Rumah Sakit Prima Husada Malang telah mencanangkan serta melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk seluruh staf serta penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan yang ada di rumah sakit.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit;

1.3 Tujuan

Program ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di rumah sakit Prima Husada Malang secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta tersusunnya sistem monitoring pelayanan rumah sakit melalui indikator mutu pelayanan.

BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

2.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
a.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit	1) Melakukan Penetapan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 2) Melakukan Penetapan Indikator Mutu Prioritas Unit 3) Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Nasional 4) Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 5) Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit 6) Melakukan validasi data pada indikator mutu sesuai standard dan kebutuhan 7) Melakukan benchmarking Dan Membuat kajian data hasil perbandingan (benchmarking)
b.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan	1) Melakukan Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>) pada indikator yang tidak mencapai target. 2) Melakukan Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan (apakah perbaikan, bertahan/ stagnan).
c.	Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i>	1) Melakukan Pengukuran PPK-<i>Clinical Pathway</i>. 2) Melakukan evaluasi hasil pengukuran CP 3) Memberikan feedback melalui Rapat koordinasi antara Komite Mutu, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan dari hasil evaluasi CP untuk meminimalkan varian asuhan
d.	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM	1) Memilih dan mengukur 1 proyek prioritas perbaikan baik dampak perbaikan primer dan sekunder (terhadap misal: ALOS, keuangan, SDM dll) yang dapat menunjukkan efisiensi dan efektifitas sumber daya. 2) Melakukan perbaikan hasil pengukuran 1 proyek prioritas yaitu IMPRS klinis dan uji coba perbaikan mutu yang berkesinambungan
e.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien	1) Membuat laporan: (laporan bulanan, triwulan tahunan) , untuk INM dikirim ke kemenkes 2) Melakukan penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel). 3) Melaksanakan analisis insiden sampai RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan 4) Melaksanakan pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien).
f.	Penerapan sasaran keselamatan pasien	1) Melakukan pengukuran penerapan 6 sasaran Keselamatan pasien yaitu : Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh. 2) Melakukan ronde keselamatan pasien secara berkala.

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
g.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen	1) Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (misal: Laboratorium luar, <i>Outsourcing</i>, Dokter Tamu) 2) Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dalam setiap kontrak kerja sama jika ada vendor yang baru
h.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien	1) Melakukan Pelatihan PMKP 2) Melaksanakan Pelatihan Pengambilan Data Mutu (PIC): • Materi: a) Indikator Mutu yang diukur di Unit b) Alur Pengumpulan Data Mutu di SIMRS c) Cara analisis permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d) Praktik mengumpulkan data mutu baik di SIMRS 3) Pelatihan terkait pengisian evaluasi CP di Unit: (Kolaborasi dengan Komite) • Sasaran: PPA (Program Pemberi Asuhan) yakni DPJP, Perawat, Bidan, Gizi dan Farmasi • Materi: a) <i>Refreshment</i> Praktik Klinis yang dilakukan Audit b) Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>
i.	Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf	1) Sosialisasi hasil capaian mutu kepada seluruh staf melalui rapat bulanan, papan pengumuman, atau media internal. 2) Pemberian <i>reward</i> bagi unit dengan capaian mutu terbaik atau pelaporan insiden tertinggi (budaya lapor).

BAB III CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

A. Pengukuran mutu indikator termasuk indikator nasional mutu (INM), indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP RS) dan indikator mutu prioritas unit (IMP Unit)

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Melakukan penetapan indikator mutu prioritas rumah sakit	a. Melakukan evaluasi indikator mutu yang belum tercapai, laporan IKP, pemantauan manajemen risiko rumah sakit dan evaluasi implementasi program komite-komite rumah sakit. b. Melakukan skoring untuk menetapkan indikator pelayanan klinis prioritas berdasarkan jumlah kasus, masalah paling banyak di RS, <i>high volume</i> , <i>high cost</i> , <i>high process</i> , ketidakpuasan pasien dan staf, kemudahan dalam pengukuran, ketentuan pemerintah, sesuai tujuan strategis RS, dan memberi pengalaman pasien yang lebih baik. c. Memfasilitasi rapat penyusunan indikator mutu prioritas rumah sakit bersama dengan komite-komite rumah sakit. d. Memfasilitasi penyusunan SK penetapan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit. e. Memfasilitasi penyusunan Kamus Indikator mutu prioritas rumah sakit.
2.	Melakukan penetapan indikator mutu prioritas unit	a. Melakukan identifikasi indikator mutu yang belum tercapai. b. Mengumpulkan usulan indikator mutu baru dari setiap unit. c. Memfasilitasi pemilihan indikator mutu prioritas dari setiap unit. d. Menyelenggarakan rapat menetapkan indikator mutu prioritas unit. e. Memfasilitasi penyusunan SK Penetapan Indikator Mutu Prioritas Unit. f. Memfasilitasi penyusunan Kamus Indikator mutu Unit.
3.	Melakukan pengukuran indikator mutu nasional	a. Melakukan sosialisasi pengukuran indikator mutu nasional. b. Melakukan pengumpulan data oleh PIC Mutu Unit dalam SIMRS. c. Melakukan analisis data capaian indikator mutu nasional setiap bulan. d. Melakukan pelaporan hasil capaian data indikator mutu nasional oleh Komite Mutu kepada Direktur RS.
4.	Melakukan pengukuran indikator mutu prioritas rumah sakit	a. Melakukan sosialisasi pengukuran indikator mutu prioritas RS. b. Melakukan pengumpulan data oleh PIC Mutu Unit dalam SIMRS. c. Melakukan analisis data capaian indikator mutu prioritas RS setiap bulan. d. Melakukan pelaporan hasil capaian data indikator mutu prioritas RS oleh Komite Mutu kepada Direktur RS.
5.	Melakukan pengukuran indikator mutu prioritas unit	a. Melakukan sosialisasi pengukuran indikator mutu prioritas unit. b. Melakukan pengumpulan data oleh PIC Mutu Unit dalam SIMRS. c. Melakukan analisis data capaian indikator mutu prioritas unit setiap 3 bulan. d. Melakukan pelaporan hasil capaian data indikator mutu prioritas unit oleh Komite Mutu kepada Direktur RS.
6.	Melakukan validasi data pada indikator	Kebijakan data yang harus divalidasi yaitu: a. Pengukuran Indikator mutu baru;

	mutu sesuai standar dan kebutuhan	b. Bila data akan dipublikasi ke masyarakat baik melalui website rumah sakit atau media lain c. Ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misalnya perubahan profil indikator, instrumen pengumpulan data, proses agregasi data, atau perubahan staf pengumpul data atau validator d. Bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya e. Bila terdapat perubahan sumber data, misalnya terdapat perubahan sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik; f. Bila terdapat perubahan subyek data seperti perubahan umur rata rata pasien, perubahan protokol riset, panduan praktik klinik baru diberlakukan, serta adanya teknologi dan metodologi pengobatan baru. Jika data memenuhi salah satu standar di atas, maka data harus dilakukan validasi dengan cara validasi oleh kepala ruang/kepala unit dilakukan dengan mencocokkan data terhadap sumber dokumen asli pada unit masing-masing.
7.	Melakukan benchmarking dan membuat kajian data hasil perbandingan (benchmarking)	a. Menentukan indikator yang akan dibenchmarking berdasarkan prioritas perbaikan mutu rumah sakit. b. Menetapkan rumah sakit atau sumber pembanding yang memiliki indikator sejenis dan relevan untuk dibandingkan. c. Mengumpulkan data capaian indikator dari internal rumah sakit dan sumber pembanding sesuai periode yang sama. d. Melakukan validasi data untuk memastikan data yang digunakan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. e. Membandingkan capaian indikator dengan menganalisis kesenjangan antara hasil internal dan data pembanding. f. Mengidentifikasi faktor penyebab perbedaan capaian melalui kajian terhadap proses kerja, kebijakan, dan strategi yang diterapkan. g. Menyusun kajian hasil benchmarking dalam bentuk analisis, interpretasi data, serta identifikasi praktik baik yang dapat diadopsi. h. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan mutu di rumah sakit. i. Melaporkan hasil benchmarking kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan implementasi perbaikan.

B. Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Melakukan Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>) pada indikator yang tidak mencapai target.	a. Melakukan identifikasi indikator mutu yang tidak mencapai target berdasarkan hasil monitoring capaian. b. Melakukan analisis akar masalah penyebab ketidaktercapaian indikator bersama unit terkait. c. Menyusun rencana perbaikan (Plan) beserta target, metode, PIC, dan waktu pelaksanaan. d. Melaksanakan uji coba tindakan perbaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan (Do). e. Melakukan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan perbaikan untuk menilai efektivitasnya (Study). f. Menetapkan tindak lanjut berupa standarisasi perbaikan yang berhasil atau penyusunan rencana perbaikan lanjutan (Action).

		g. Melakukan monitoring berkala untuk memastikan hasil perbaikan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
2.	Melakukan Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan (apakah perbaikan, bertahan/ stagnan).	a. Melakukan monitoring hasil tindak lanjut perbaikan terhadap indikator mutu yang telah dilakukan intervensi. b. Melakukan pengumpulan dan analisis data capaian indikator setelah pelaksanaan perbaikan. c. Membandingkan capaian indikator sebelum dan sesudah tindak lanjut perbaikan dilakukan. d. Mengidentifikasi apakah hasil perbaikan mengalami peningkatan, bertahan, atau stagnan terhadap target yang ditetapkan. e. Melakukan evaluasi efektivitas tindakan perbaikan bersama unit terkait. f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut apabila hasil perbaikan belum mencapai target atau masih stagnan. g. Melaporkan hasil evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan kepada Direktur RS dan unit terkait.

C. Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan *clinical pathway*

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Melakukan Pengukuran PPK- <i>Clinical Pathway</i> .	a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pengukuran kepatuhan PPK-Clinical Pathway kepada unit terkait. b. Melakukan pengumpulan data kepatuhan pelaksanaan Clinical Pathway sesuai diagnosis yang ditetapkan. c. Melakukan verifikasi dan validasi data hasil pengukuran. d. Melakukan analisis capaian kepatuhan pelaksanaan Clinical Pathway secara berkala. e. Melaporkan hasil pengukuran kepada Komite Mutu dan Komite Medik.
2.	Melakukan evaluasi hasil pengukuran CP	a. Melakukan telaah hasil capaian pengukuran Clinical Pathway. b. Mengidentifikasi adanya variasi pelaksanaan asuhan yang tidak sesuai standar. c. Menganalisis faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan Clinical Pathway. d. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. e. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.
3.	Memberikan feedback melalui Rapat koordinasi antara Komite Mutu, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan dari hasil evaluasi CP untuk meminimalkan varian asuhan	a. Menyusun bahan paparan hasil evaluasi Clinical Pathway. b. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Komite Mutu, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan. c. Menyampaikan hasil evaluasi dan temuan variasi pelaksanaan asuhan. d. Membahas akar masalah dan alternatif solusi perbaikan bersama. e. Menetapkan tindak lanjut perbaikan untuk meminimalkan varian asuhan klinis. f. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat koordinasi.

D. Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
----	------------------	----------------------------

1.	Memilih dan mengukur 1 proyek prioritas perbaikan baik dampak perbaikan primer dan sekunder (terhadap misal: ALOS, keuangan, SDM dll) yang dapat menunjukkan efisiensi dan efektifitas sumber daya.	a. Melakukan identifikasi proyek prioritas perbaikan berdasarkan hasil analisis capaian indikator mutu rumah sakit. b. Menetapkan satu proyek prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan. c. Menentukan indikator pengukuran dampak primer dan sekunder seperti ALOS, biaya, utilisasi SDM, dan mutu pelayanan. d. Melakukan pengumpulan data awal sebagai baseline pengukuran. e. Melaksanakan pengukuran dampak proyek secara berkala sesuai periode evaluasi. f. Melakukan analisis hasil pengukuran untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. g. Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.
2.	Melakukan perbaikan hasil pengukuran 1 proyek prioritas yaitu IMPRS klinis dan uji coba perbaikan mutu yang berkesinambungan	a. Melakukan analisis hasil pengukuran proyek prioritas yang belum mencapai target. b. Mengidentifikasi akar masalah penyebab ketidaktercapaian capaian IMPRS klinis. c. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil analisis. d. Melaksanakan uji coba intervensi perbaikan mutu pada unit terkait. e. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil uji coba perbaikan secara berkala. f. Menetapkan tindak lanjut berupa standarisasi apabila perbaikan berhasil atau revisi intervensi apabila hasil belum optimal. g. Mendokumentasikan seluruh proses perbaikan sebagai bagian dari peningkatan mutu berkesinambungan.

E. Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Membuat laporan: (laporan bulanan, triwulan tahunan) , untuk INM dikirim ke kemenkes	a. Melakukan pengumpulan data capaian indikator mutu dari seluruh unit sesuai periode pelaporan. b. Melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dikumpulkan. c. Melakukan analisis capaian indikator dan menyusun interpretasi hasil pengukuran. d. Menyusun laporan mutu bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai format yang ditetapkan. e. Melakukan pelaporan indikator nasional mutu melalui sistem pelaporan Kementerian Kesehatan sesuai jadwal yang ditentukan. f. Menyampaikan laporan kepada pimpinan rumah sakit sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
2.	Melakukan penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel).	a. Melakukan sosialisasi alur pelaporan insiden keselamatan pasien kepada seluruh staf. b. Memastikan ketersediaan formulir atau media pelaporan insiden yang mudah diakses. c. Melakukan pendampingan kepada unit dalam pelaksanaan pelaporan insiden. d. Melakukan monitoring kepatuhan pelaporan insiden di seluruh unit pelayanan. e. Melakukan evaluasi efektivitas alur pelaporan dan perbaikan bila diperlukan.
3.	Melaksanakan analisis insiden sampai RCA (Root	a. Melakukan identifikasi dan verifikasi insiden signifikan yang memerlukan analisis mendalam.

	<i>Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan	b. Membentuk tim analisis insiden sesuai ketentuan rumah sakit. c. Melakukan investigasi dan pengumpulan data terkait kejadian insiden. d. Melaksanakan analisis akar masalah menggunakan metode Root Cause Analysis. e. Menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil RCA. f. Melakukan monitoring implementasi rekomendasi perbaikan.
4.	Melaksanakan pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien).	a. Mengumpulkan data insiden keselamatan pasien yang wajib dilaporkan. b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan validitas data laporan insiden. c. Menyusun laporan insiden sesuai format pelaporan KNKP. d. Menginput dan mengirimkan laporan secara berkala melalui sistem pelaporan yang ditetapkan. e. Mendokumentasikan bukti pelaporan sebagai arsip rumah sakit. f. Melakukan tindak lanjut atas umpan balik dari KNKP apabila ada.

F. Penerapan sasaran keselamatan pasien

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Melakukan pengukuran penerapan 6 sasaran Keselamatan pasien yaitu : Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh.	a. Menyusun jadwal pelaksanaan audit penerapan 6 sasaran keselamatan pasien di seluruh unit pelayanan. b. Menyiapkan instrumen pengukuran sesuai standar sasaran keselamatan pasien. c. Melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung, telaah dokumen, dan wawancara petugas. d. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengukuran. e. Melakukan analisis capaian kepatuhan penerapan masing-masing sasaran keselamatan pasien. f. Menyusun laporan hasil pengukuran dan menyampaikan kepada unit terkait. g. Menetapkan rekomendasi tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
2.	Melakukan ronde keselamatan pasien secara berkala.	a. Menyusun jadwal ronde keselamatan pasien secara berkala bersama tim terkait. b. Menetapkan tim ronde yang terdiri dari unsur manajemen, komite mutu, dan unit pelayanan. c. Melaksanakan observasi langsung ke unit pelayanan untuk mengidentifikasi potensi risiko keselamatan pasien. d. Mendokumentasikan temuan hasil ronde keselamatan pasien. e. Menyampaikan umpan balik langsung kepada unit terkait atas temuan yang didapatkan. f. Menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut atas temuan ronde keselamatan pasien. g. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil ronde secara berkala.

G. Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga	a. Mengidentifikasi pihak ketiga yang menjadi objek evaluasi mutu layanan. b. Menetapkan indikator evaluasi mutu sesuai jenis layanan yang diberikan.

	(misal: Laboratorium luar, <i>Outsourcing</i> , Dokter Tamu)	c. Melakukan pengumpulan data capaian mutu melalui audit, monitoring, dan telaah laporan pelayanan. d. Melakukan analisis kesesuaian capaian layanan terhadap standar atau target yang telah ditetapkan. e. Mengidentifikasi kendala atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan layanan. f. Menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada pihak ketiga terkait. g. Melakukan tindak lanjut dan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi.
2.	Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dalam setiap kontrak kerja sama jika ada vendor yang baru	a. Melakukan identifikasi ruang lingkup layanan yang akan dikerjasamakan dengan vendor baru. b. Menentukan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sesuai jenis layanan. c. Menyusun target capaian KPI berdasarkan standar mutu rumah sakit dan ketentuan yang berlaku. d. Melakukan pembahasan KPI bersama pihak vendor sebelum penandatanganan kontrak. e. Mencantumkan indikator kinerja dan target capaian dalam dokumen kontrak kerja sama. f. Melakukan sosialisasi KPI kepada unit terkait sebagai dasar monitoring pelaksanaan kontrak. g. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian KPI vendor sebagai dasar penilaian kinerja.

H. Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Melakukan Pelatihan PMKP	a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan PMKP bagi seluruh staf sesuai hasil evaluasi program mutu. b. Menyusun materi pelatihan sesuai kebijakan, standar akreditasi, dan kebutuhan rumah sakit. c. Menetapkan jadwal, narasumber, dan peserta pelatihan PMKP. d. Melaksanakan pelatihan PMKP kepada seluruh staf sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. e. Melakukan evaluasi pemahaman peserta melalui pre-test, post-test, atau evaluasi praktik. f. Mendokumentasikan hasil pelatihan sebagai bahan monitoring kompetensi staf.
2.	Melaksanakan Pelatihan Pengambilan Data Mutu (PIC)	a. Menetapkan PIC mutu unit sebagai peserta pelatihan pengambilan data. b. Menyusun materi pelatihan terkait definisi operasional indikator dan tata cara pengumpulan data. c. Memberikan pelatihan teknis pengisian, pencatatan, dan pelaporan data mutu sesuai format yang ditetapkan. d. Melaksanakan simulasi pengambilan dan input data mutu. e. Melakukan evaluasi kompetensi peserta dalam pengambilan data. f. Melakukan pendampingan pasca pelatihan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan di unit.
3.	Pelatihan terkait pengisian evaluasi CP di Unit	a. Menyusun materi pelatihan pengisian formulir evaluasi Clinical Pathway. b. Menetapkan peserta pelatihan dari unit pelayanan yang melaksanakan Clinical Pathway. c. Memberikan penjelasan terkait tata cara pengisian, kelengkapan data, dan kriteria evaluasi Clinical Pathway. d. Melaksanakan praktik simulasi pengisian evaluasi Clinical Pathway.

		e. Melakukan evaluasi hasil pemahaman peserta terhadap pengisian evaluasi CP. f. Melakukan monitoring dan pendampingan pelaksanaan pengisian evaluasi CP di unit secara berkala.
--	--	--

I. Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Sosialisasi hasil capaian mutu kepada seluruh staf melalui rapat bulanan, papan pengumuman, atau media internal.	a. Mengumpulkan dan menyusun hasil capaian indikator mutu dari seluruh unit secara periodik. b. Melakukan analisis data capaian mutu untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. c. Menyusun materi sosialisasi dalam bentuk laporan, grafik, atau media informasi lainnya. d. Menyampaikan hasil capaian mutu melalui rapat bulanan, papan pengumuman, atau media internal rumah sakit. e. Memberikan penjelasan terkait hasil capaian, kendala, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. f. Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi sebagai bukti komunikasi hasil mutu kepada seluruh staf.
2.	Pemberian <i>reward</i> bagi unit dengan capaian mutu terbaik atau pelaporan insiden tertinggi (budaya lapor).	a. Menetapkan kriteria penilaian pemberian reward berdasarkan capaian indikator mutu atau kepatuhan pelaporan insiden. b. Melakukan rekapitulasi dan verifikasi data capaian dari seluruh unit. c. Melakukan penilaian unit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. d. Menetapkan unit penerima reward melalui rapat evaluasi bersama tim terkait. e. Memberikan penghargaan kepada unit terpilih dalam forum resmi rumah sakit. f. Melakukan publikasi hasil pemberian reward sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien.

BAB IV SASARAN

4.1 Sasaran Kegiatan PMKP

No	Kegiatan Pokok	Sasaran
a.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit	Tersedianya sistem pengukuran mutu yang terstandar, akurat, valid, dan berkesinambungan sebagai dasar evaluasi capaian mutu pelayanan rumah sakit.
b.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan	Terlaksananya upaya perbaikan mutu secara sistematis dan berkelanjutan sehingga indikator mutu yang belum mencapai target dapat meningkat dan hasil perbaikan dapat dipertahankan.
c.	Mengurangi varian dalam praktik klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan Clinical Pathway	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar praktik klinis sehingga variasi pelayanan dapat diminimalkan dan mutu asuhan klinis lebih konsisten.
d.	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya	Terukurnya dampak perbaikan mutu terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan efektivitas pelayanan, dan optimalisasi kinerja rumah sakit.
e.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien	Meningkatkan budaya pelaporan insiden keselamatan pasien, memperkuat sistem pembelajaran dari insiden, serta mencegah terulangnya kejadian serupa melalui tindak lanjut perbaikan.
f.	Penerapan sasaran keselamatan pasien	Meningkatkan kepatuhan seluruh staf terhadap penerapan enam sasaran keselamatan pasien guna menjamin keselamatan pasien dalam proses pelayanan.
g.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen	Memastikan mutu layanan pihak ketiga sesuai standar rumah sakit dan seluruh kerja sama memiliki indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi.
h.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien	Meningkatkan kompetensi seluruh staf dalam pelaksanaan program PMKP, pengelolaan data mutu, serta implementasi evaluasi clinical pathway sesuai peran masing-masing.
i.	Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf	Meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi seluruh staf dalam mendukung budaya mutu dan keselamatan pasien melalui komunikasi hasil capaian mutu secara terbuka dan berkelanjutan.

BAB V
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Skedul Kegiatan PMKP	2026												KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pengukuran mutu indikator termasuk indikator national mutu (INM), indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP RS) dan indikator mutu prioritas unit (IMP unit)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan.			√			√			√			√	
3.	Mengurangi variasi dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/ Algoritme/ Protokol dalam melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i> .			√			√			√			√	
4.	Mengukur dampak efisiensi dan efektifitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM.			√			√			√			√	
5.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien	Setiap ada insiden keselamatan pasien												
6.	Penerapan sasaran keselamatan pasien.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen									√				
8.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dlam program								√					

	peningkatan mutu dan keselamatan pasien.												
9.	Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf.			√			√			√			√

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS Prima Husada Malang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai jadwal evaluasi yang telah ditetapkan rumah sakit.
2. Diselenggarakan oleh Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) bersama pimpinan RS Prima Husada Malang.
3. Melibatkan seluruh unit terkait dalam penyampaian laporan capaian indikator mutu dan keselamatan pasien.
4. Melakukan penilaian terhadap capaian indikator mutu unit, indikator mutu prioritas, dan indikator keselamatan pasien berdasarkan hasil monitoring periode berjalan.
5. Melakukan analisis tren capaian indikator untuk mengetahui peningkatan, penurunan, maupun stabilitas pencapaian mutu pelayanan.
6. Mengidentifikasi kendala, hambatan, dan akar masalah pada indikator yang belum mencapai target.
7. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.
8. Menyusun rekomendasi serta rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
9. Hasil evaluasi didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
10. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun budaya mutu dan keselamatan pasien di RS Prima Husada Malang.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pencatatan kegiatan dilakukan setiap bulan oleh koordinator pada masing-masing unit sesuai indikator yang telah ditetapkan.
2. Data hasil pencatatan direkapitulasi oleh masing-masing unit/instalasi setiap akhir periode pelaporan.
3. Hasil rekapitulasi dikumpulkan pada masing-masing instalasi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan data.
4. Data yang telah lengkap selanjutnya dilaporkan kepada Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RS Prima Husada Malang.
5. Komite PMKP melakukan verifikasi terhadap data yang diterima dari setiap instalasi.
6. Data yang telah diverifikasi dilakukan analisis untuk menilai capaian indikator dan pelaksanaan program.
7. Hasil analisis digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
8. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun rekomendasi tindak lanjut sebagai upaya perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.